

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA DE DESESPERANZA DE BECK (BHS)

Beck Hopelessness Scale (Beck, Weissman, Lester & Trexler, 1974) · Adaptación Española (Viñas et al., 2004; Aguilar et al., 1995)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala de Desesperanza de Beck (Beck Hopelessness Scale, BHS)
Sigla / Acrónimo	BHS
Autoría original	Aaron T. Beck, Arlene Weissman, David Lester & Larry Trexler (Univ. of Pennsylvania, 1974)
Adaptación en español	Viñas, Villar, Caparrós et al. (2004, Int J Clin Health Psychol); Aguilar et al. (1995)
Constructo evaluado	Actitudes cognitivas pesimistas sobre el futuro y expectativas negativas sobre el bienestar personal
Población diana	Adolescentes (≥ 13 años) y adultos en riesgo de suicidio, depresión o toxicomanías
Tiempo de aplicación	3 a 5 minutos (autoadministrado)
Estructura y formato	20 afirmaciones dicotómicas (Verdadero / Falso), 9 formuladas en sentido positivo y 11 en sentido negativo
Condiciones de uso	Propiedad de Pearson Clinical Assessment; distribuido bajo licencia psicométrica oficial

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La desesperanza se define operativamente como un sistema de esquemas cognitivos rígidos en los que predominan expectativas altamente negativas respecto al futuro, asociadas a la convicción de que los problemas actuales son insolubles y de que nada de lo que el individuo haga modificará su destino adverso. En el modelo cognitivo de Beck, la desesperanza es el componente nuclear de la tercera vertiente de la Tríada Cognitiva (el futuro).

Estudios longitudinales prospectivos seminales (Beck et al., 1985, 1990) demostraron que la desesperanza no es solo un síntoma depresivo más, sino el predictor psicológico independiente más potente de suicidio consumado a medio y largo plazo. Pacientes con puntuaciones elevadas de desesperanza tienen un riesgo hasta **11 veces mayor** de consumir el suicidio en los siguientes 5 a 10 años que aquellos con depresión de igual intensidad pero baja desesperanza.

3. ESTRUCTURA FACTORIAL DE LA ESCALA BHS

Factor Teórico	Nº Ítems	Rango	Contenido y Actitud Evaluada
1. Sentimientos sobre el Futuro	5 ítems	0 - 5	Entusiasmo, esperanza, optimismo afectivo y fe en el mañana (ítems 1, 5, 6, 13, 15)
2. Pérdida de Motivación	8 ítems	0 - 8	Rendición conativa, desinterés por luchar y falta de iniciativa vital (ítems 2, 3, 9, 11, 12, 16, 17, 20)
3. Expectativas Futuras	7 ítems	0 - 7	Anticipación de fracaso, oscuridad, pesimismo cognitivo y fatalismo (ítems 4, 7, 8, 10, 14, 18, 19)

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y CAPACIDAD PREDICTIVA

Consistencia interna	Excelente fiabilidad; alfa de Cronbach $\alpha = 0.88 - 0.93$ en muestras psiquiátricas con tentativa de suicidio y $\alpha = 0.84$ en población española universitaria (Viñas et al., 2004).
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 6 semanas con $r = 0.69 - 0.74$, demostrando que combina la estabilidad de un esquema cognitivo basal con cierta reactividad clínica a la psicoterapia.
Valor predictivo de suicidio	En estudios prospectivos de seguimiento a 10 años (Beck et al., 1990), un punto de corte ≥ 9 predijo el 90.4% de los suicidios consumados en pacientes psiquiátricos ingresados.
Validez convergente	Correlación positiva muy alta con la Escala de Ideación Suicida (BSS, $r = 0.68$), depresión BDI-II ($r = 0.64$) y correlación negativa con razones para vivir RFL ($r = -0.71$).
Estructura factorial	Análisis factoriales confirmatorios demuestran solidez del modelo trifactorial propuesto por Beck, con un factor general de desesperanza de orden superior.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Codificación de aciertos	Se asigna 1 punto a cada respuesta que indique desesperanza / pesimismo y 0 puntos a la respuesta optimista.
Ítems directos (Verdadero = 1)	Los 11 ítems redactados negativamente suman 1 punto si se contesta "Verdadero": 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18 y 20.
Ítems invertidos (Falso = 1)	Los 9 ítems formulados en sentido optimista suman 1 punto si se contesta "Falso": 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15 y 19.
Puntuación directa total	Suma aritmética simple de los 20 ítems. Rango teórico posible: 0 a 20 puntos . A mayor puntuación, mayor desesperanza y riesgo vital.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación BHS	Percentil Aprox.	Nivel de Desesperanza	Riesgo Suicida y Conducta Clínica
0 - 3 puntos	< Pc 50	Ninguna / Mínima	Visión optimista o adaptativa del porvenir; riesgo autolítico basal muy bajo.
4 - 8 puntos	Pc 55 - Pc 75	Desesperanza Leve	Incertidumbre o dudas sobre el futuro; mantener seguimiento ambulatorio.
9 - 14 puntos	Pc 80 - Pc 94	Desesperanza Moderada	Punto de corte crítico de alarma; riesgo suicida significativamente aumentado.
15 - 20 puntos	$\geq$ Pc 95	Desesperanza Severa	Visión de túnel cognitivo; riesgo inminente de suicidio y abandono vital.

PUNTO DE CORTE CRÍTICO PROSPECTIVO (BECK ET AL.):

- BHS ≥ 9 puntos:** Identifica al 90% de los pacientes que consumarán suicidio en estudios de cohortes. Todo paciente con BHS ≥ 9 debe ser considerado en **Alto Riesgo Suicida**, independientemente de que niegue ideación autolítica explícita en ese momento.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE DESESPERANZA Y RIESGO AUTOLÍTICO

Paso 1: Aplicación del BHS: Calcular puntuación total (0 a 20).

Paso 2: Si BHS 0 — 8 (Mínima a Leve): Abordaje psicoterapéutico ordinario de los estresores vitales; reforzar motivos para vivir.

Paso 3: Si BHS 9 — 14 (Desesperanza Moderada - Umbral Crítico):

- Realizar entrevista clínica exhaustiva sobre planes o métodos de suicidio (BSS / C-SSRS).
- Confeccionar un **Plan de Seguridad** por escrito (Stanley & Brown): señales de alarma personales, estrategias de distracción autónomas, personas de apoyo y teléfonos de emergencia (024 / 112).
- Retirar o custodiar por parte de un familiar todo acceso a métodos letales (psicofármacos acumulados, armas, tóxicos).

Paso 4: Si BHS 15 — 20 (Desesperanza Severa): Derivación urgente a guardia de Psiquiatría; valorar ingreso hospitalario si carece de soporte familiar continente.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN GESTIÓN DEL RIESGO SUICIDA

Identificación: Paciente varón de 53 años, pequeño empresario en concurso de acreedores, atendido en Salud Mental tras acudir a urgencias por una crisis de ansiedad aguda. En la entrevista inicial se mostraba distante y sonriente, minimizando sus quejas.

Evaluación Inicial BHS: Puntuación Total = **17 / 20** (Desesperanza Severa, Percentil 98).

- Respuestas críticas: Ítem 2 (V = "Podría rendirme"), Ítem 4 (V = "No puedo imaginar cómo será mi vida en 10 años"), Ítem 7 (V = "Mi futuro me parece oscuro"), Ítem 14 (V = "Las cosas no van a salir como yo quiero"), Ítem 20 (V = "No tiene sentido intentar nada").

Intervención Inmediata: A pesar de que el paciente intentaba tranquilizar al médico asegurando que "todo estaba bien", la discrepancia entre su fachada sonriente y el BHS de 17 activó la alerta clínica. Se citó a su cónyuge, quien descubrió una carta de despedida en su maletín.

Manejo: Ingreso breve en Unidad de Hospitalización Breve para contención farmacológica y estabilización; posterior psicoterapia cognitivo-conductual centrada en resolución de problemas y reestructuración de la desesperanza. Al alta a los 2 meses, el BHS se redujo a **5 / 20**.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo Vital:

- **Calma Repentina Sospechosa:** Un paciente deprimido que se muestra súbitamente sereno y en paz pero mantiene BHS ≥ 9 puede haber tomado ya la decisión firme de suicidarse.
- **Dolor Incurable y Aislamiento:** En ancianos que viven solos con dolor crónico y BHS elevado, el riesgo letal se dispara.

Diagnóstico Diferencial:

- **Desesperanza vs. Depresión:** La desesperanza es el nexo causal directo entre la depresión y el acto suicida; puede haber depresión sin desesperanza.
- **Realismo Pesimista Transitorio:** Crisis económicas o enfermedades somáticas graves con pronóstico infausto que generan pesimismo situacional.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L. (1974). The measurement of pessimism: the Hopelessness Scale. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 42(6), 861-865. <https://doi.org/10.1037/h0037562>
- Beck, A. T., Steer, R. A., Kovacs, M., & Garrison, B. (1985). Hopelessness and eventual suicide: a 10-year prospective study of patients hospitalized with suicidal ideation. *The American Journal of Psychiatry*, 142(5), 559-563.
- Beck, A. T., Brown, G., Berchick, R. J., Stewart, B. L., & Steer, R. A. (1990). Relationship between hopelessness and ultimate suicide: a replication with psychiatric outpatients. *The American Journal of Psychiatry*, 147(2), 190-195.
- Viñas, F., Villar, E., Caparrós, B., Juan, J., Cornellà, M., & Pérez, I. (2004). Feelings of hopelessness in a Spanish university population: its relationship with depression, suicide ideation, and life events. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 4(2), 303-319.